UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMÁS DE AQUINO
Facultad de Ciencias de la Salud — Licenciatura en Nutrición
CÁTEDRA DE NUTRICIÓN INFANTIL — EVALUACIÓN PARCIAL

RECUPERATORIO 2° PARCIAL

CLAVE DOCENTE

Apellido y Nombre: _____ **UP :** _____

Pregunta	A	B	C	D
Pregunta 1	[ ] A	[ ] B	**[X] C**	[ ] D
Pregunta 2	[ ] A	[ ] B	**[X] C**	[ ] D
Pregunta 3	[ ] A	[ ] B	**[X] C**	[ ] D
Pregunta 4	[ ] A	[ ] B	**[X] C**	[ ] D
Pregunta 5	[ ] A	[ ] B	**[X] C**	[ ] D

INSTRUCCIONES

- Marque con una **X** una sola opción por pregunta.
- Las respuestas con más de una marca se considerarán incorrectas.
- No se aceptan tachaduras ni uso de corrector.

NOTA FINAL

/ 10 PUNTOS

(Cada pregunta vale 2 puntos)

---

1. De acuerdo con el protocolo estandarizado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cuál es el sitio anatómico exacto de referencia para la medición de la circunferencia de cintura?

a) Inmediatamente por encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha.
b) Tres centímetros por debajo del centro de la cicatriz umbilical.
c) **[X] En el punto medio equidistante entre el borde inferior de la última costilla palpable y la cresta ilíaca.**
d) Sobre el reborde costal anterior a nivel de la apófisis xifoides del esternón.

2. Para ubicar y marcar el punto mesobraquial (punto medio del brazo), ¿cuáles son los dos puntos óseos de referencia anatómica que se deben palpar con el codo flexionado a 90°?

a) El extremo distal de la clavícula y la apófisis estiloides del radio en la muñeca.
b) El ángulo inferior de la escápula y la fosa antecubital del pliegue del codo.
c) **[X] El borde superolateral del acromion y el punto más distal del olécranon.**
d) La tuberosidad mayor del húmero y la apófisis coronoides del cúbito.

3. En la evaluación antropométrica de la circunferencia de cintura (sea por protocolo CDC u OMS), ¿en qué momento del ciclo respiratorio debe efectuarse la lectura de la cinta métrica?

a) En el momento de máxima inspiración pulmonar conteniendo el aire durante tres segundos.
b) En cualquier instante indistinto mientras el paciente conversa activamente con el evaluador.
c) **[X] Al final de una espiración normal y no forzada, con el abdomen suave y relajado.**
d) Inmediatamente después de pedirle al niño que hunda y contraiga activamente la pared abdominal.

4. ¿Por qué las algas como la espirulina, nori o chlorella NO deben utilizarse como fuente de Vitamina B12 en la alimentación de niños y adolescentes?

a) Porque aportan concentraciones tóxicas de cobalamina que sobrecargan la función renal pediátrica.
b) Porque inhiben la proliferación de glóbulos blancos durante el proceso digestivo entérico.
c) **[X] Porque contienen pseudovitamina B12 (análogos inactivos que bloquean los receptores ileales y falsean los análisis en sangre).**
d) Porque requieren hervirse durante un período continuo de más de 8 horas para activarse biológicamente.

5. ¿Qué combinación alimentaria en el almuerzo permite optimizar y hasta triplicar la absorción del hierro vegetal (no hemínico) aportado por las legumbres?

a) Consumir el plato junto con un vaso de leche entera de vaca o yogur bebible.
b) Tomar una taza de té negro concentrado o mate cocido caliente junto con la comida.
c) **[X] Acompañar la comida con una fuente de Vitamina C fresca (como pimiento morrón crudo, tomate fresco o frutas cítricas).**
d) Espolvorear salvado de trigo seco sin remojar sobre la preparación caliente.